

FÜR NIEDERGELASSENE ZAHNÄRZTINNEN UND ZAHNÄRZTE

Nach dem Heil- und Kostenplan

Wirtschaftliche Aufklärung beim Eigenanteil, ohne die Rolle der Praxis zu verlassen

Arbeitsunterlage

Arbeitsunterlage für Praxis und Team, keine Patienteninformation. Ob eine Praxis neutrale Information auslegt, entscheidet sie selbst. Diese Unterlage ist keine Rechtsberatung.

Stand 23.09.2026 · Healio GmbH, Hamburg

Worum es geht

Der Plan liegt auf dem Tisch. Sie haben erklärt, was medizinisch sinnvoll ist, was die Kasse trägt und was davon offen bleibt. Der Patient nimmt das Papier mit, sagt, er überlege es sich noch einmal, und danach hören Sie nichts mehr.

In den wenigsten Fällen ist das eine Entscheidung gegen die Behandlung. Meistens ist es eine Entscheidung gegen einen Betrag, für den im Moment kein Platz im Haushalt ist. Ausgesprochen wird das selten. Es ist unangenehm, und am Empfang ist selten der richtige Ort dafür.

Trotzdem lohnt es sich, kurz hinzusehen, was da eigentlich passiert. Der Patient kommt mit Vertrauen zu Ihnen. Er fragt links und rechts nach, wie das mit den Abrechnungen läuft, und er verschiebt am Ende den Termin, weil ihm niemand gesagt hat, dass es überhaupt einen Prüfweg gibt. Es ist eine Schande, dass Menschen ihre Behandlung abbrechen und ihre Rechnungen still selbst bezahlen, während im selben Jahr Beträge bei ihrer Kasse liegen bleiben. Niemand ruft sie ab, weil es ihnen niemand sagt.

Daraus folgt für die Praxis kein Auftrag, jemanden anzusprechen. Es folgt daraus nur eines: Wer fragt, bekommt eine ehrliche Antwort und den Hinweis, dass es einen Prüfweg gibt. Ohne Scheu, ohne Umschweife und ohne dass sich jemand dafür schämen müsste.

Der betriebswirtschaftliche Teil davon lässt sich offen aussprechen, denn Sie sehen ihn ohnehin. Ein Plan, der nicht angenommen wird, kostet zweimal: den Patienten die Behandlung, die er eigentlich braucht, und die Praxis die Stunde im Kalender. Je mehr Patienten einen Zusatzschutz haben, desto mehr Heil- und Kostenpläne werden angenommen. Das ist für die Praxis schlicht mehr Umsatz, und daran ist nichts Anrüchiges. Werben darf eine Praxis dafür nicht, das bleibt so. Neutral auslegen darf sie, und genau um diese Unterscheidung geht es auf den nächsten Seiten.

Dazu gehört noch eine Einordnung, damit klar ist, wer hier schreibt. Die Healio GmbH ist nicht an einen einzelnen Anbieter gebunden und sieht sich je Patient an, welcher Weg zu seiner Situation passt. Deshalb passt eine neutrale Auslage überhaupt zur Rolle der Praxis: Was ausliegt, steuert niemanden auf ein bestimmtes Produkt zu, sondern auf einen Prüfweg, an dessen Ende der Patient selbst entscheidet.

Diese Unterlage beschreibt, was eine Praxis an dieser Stelle sagen darf und wo ihre Rolle endet. Sie ist eine Arbeitsunterlage für Sie und Ihr Team, kein Text für das Wartezimmer.

1. Die wirtschaftliche Aufklärungspflicht nach § 630c Abs. 3 BGB

Die Vorschrift ist bekannt, wird im Alltag aber meist auf das Formular reduziert. § 630c Abs. 3 BGB verpflichtet die Behandlungsseite, den Patienten vor Beginn der Behandlung in Textform über die voraussichtlichen Kosten zu informieren, wenn sie weiß oder hinreichende Anhaltspunkte dafür hat, dass eine vollständige Übernahme durch einen Dritten nicht gesichert ist. Dritter ist in der Regel die gesetzliche Krankenkasse.

Der praktische Kern daran: Der Gesetzgeber geht davon aus, dass die Kostenfrage in das Behandlungsgespräch gehört. Nicht als Verkaufsgespräch, sondern als Teil einer Aufklärung, die den Patienten in die Lage versetzt, selbst zu entscheiden. Wer über einen Eigenanteil spricht, verlässt seine Rolle also nicht, sondern füllt sie aus.

Drei Punkte daraus sind im Alltag die, an denen es hakt.

Erstens die Textform. Mündlich reicht nicht, und ein Heil- und Kostenplan, den niemand erläutert hat, erfüllt den Zweck nur auf dem Papier. Zweitens der Zeitpunkt. Die Information gehört vor den Beginn der Behandlung, also in die Phase, in der der Patient noch frei entscheiden kann. Drittens der Auslöser. Es genügen hinreichende Anhaltspunkte dafür, dass die Kasse nicht vollständig trägt. Ob der Patient von sich aus fragt, spielt dafür keine Rolle.

Was die Vorschrift nicht regelt, ist die Frage, die der Patient danach hat. Sie lautet nicht „wie hoch ist der Betrag“, sondern „wo soll der Betrag herkommen“. Auf diese zweite Frage gibt das Gesetz keine Antwort, und die Praxis schuldet sie auch nicht. Sie steht trotzdem im Raum, und sie entscheidet oft darüber, ob der Plan umgesetzt wird.

Genau hier setzt die Überlegung an, um die es in dieser Unterlage geht: Eine neutrale Information über Prüfwege flankiert diese Pflicht, statt Fremdwerbung in die Praxis zu tragen. Das ist die Einordnung, und sie ist bewusst schmal gehalten. Eine Rechtsberatung ist sie nicht.

2. Die Linie der passiven Auslage

Die gesamte Konstruktion steht und fällt mit einem Unterschied, der in der Praxis banal wirkt und berufsrechtlich der entscheidende ist.

Auslegen heißt: Material liegt an einem Ort, an dem Patienten es sehen können. Am Tresen, im Wartebereich, im Ständer neben den übrigen Unterlagen. Niemand aus dem Team spricht jemanden darauf an. Es wandert nicht in die Mappe und wird beim Verabschieden auch nicht mitgegeben.

Aushändigen heißt: Jemand aus dem Team gibt es jemandem in die Hand, meist mit einem Satz dazu. Das ist etwas anderes, auch wenn es freundlich gemeint ist.

Die Linie, die diese Unterlage beschreibt, ist ausschließlich die erste. Material liegt aus, das Team spricht niemanden darauf an, und wer fragt, bekommt es in die Hand. Beim Patienten liegt die Initiative, und zwar vollständig.

Für das Team lässt sich das auf einen Satz bringen: Wir bieten nichts an, wir haben etwas da. Wer fragt, bekommt eine Antwort, und zwar eine richtige. Wer nicht fragt, merkt von der ganzen Sache nichts.

Passiv heißt dabei passiv im Zugehen, nicht passiv im Antworten. Wer von sich aus fragt, hat die Tür selbst geöffnet, und dann ist ein ausweichendes „da können wir nichts sagen“ die schlechtere Antwort. Die bessere lautet: Es gibt einen Prüfungsweg, sehen Sie sich den an, entscheiden müssen Sie selbst.

Diese Reihenfolge ist kein Formalismus. Sie ist der Unterschied zwischen einer Praxis, die auf eine Patientenfrage reagiert, und einer Praxis, die von sich aus etwas in den Behandlungsraum trägt, das

dort nicht hingehört.

Im Betrieb bedeutet das ein paar konkrete Festlegungen, die man einmal schriftlich treffen sollte, weil sie sonst nach zwei Wochen aufweichen.

Der Ort ist definiert und wird nicht erweitert. Wenn das Material am Tresen liegt, liegt es nur dort. Es wandert nicht in die Behandlungszimmer und nicht in die Terminmappe. Die Zahl der Exemplare bleibt klein genug, dass es nach Auslage aussieht und nicht nach Kampagne.

Es wird nicht mit dem Heil- und Kostenplan verbunden. Also kein Beiblatt und kein gemeinsamer Umschlag. Sobald beides zusammen über den Tresen geht, ist es kein Auslegen mehr, auch wenn niemand ein Wort dazu gesagt hat.

Das Team wird informiert, aber nicht beauftragt. Der Unterschied ist hörbar: „Falls jemand fragt, das liegt vorne“ ist etwas anderes als „sprecht die Leute darauf an“. Wer neu anfängt, bekommt genau diesen Satz und keine erweiterte Fassung.

Und es wird nicht nachgehakt. Wenn ein Patient beim nächsten Termin nichts dazu sagt, sagt die Praxis auch nichts. Die Nachfrage wäre der Moment, in dem aus passiver Auslage eine Ansprache wird.

3. Warum diese Unterscheidung berufsrechtlich die saubere ist

Zur Werbung in Praxisräumen gibt es Rechtsprechung. Einschlägig ist hier: BGH, Urteil vom 09.11.2010, Az. I ZR 111/08.

Mehr als diese Einordnung soll an dieser Stelle nicht stehen. Die Entscheidung wird hier zitiert, weil sie der Anker für die Linie der passiven Auslage ist, und nicht, um daraus eine Auslegung für Ihren konkreten Fall abzuleiten. Ob und wie sie auf eine bestimmte Auslage in einer bestimmten Praxis passt, beurteilt die zuständige Kammer, gegebenenfalls anwaltlich begleitet. Diese Unterlage beurteilt es ausdrücklich nicht.

Was sich sagen lässt, ohne in die Auslegung zu gehen: Je weiter sich ein Vorgehen von der aktiven Ansprache entfernt und je mehr die Entscheidung beim Patienten bleibt, desto weniger Angriffsfläche entsteht. Deshalb ist die Linie so eng gezogen, wie sie ist. Nicht weil ein größerer Spielraum bequemer wäre, sondern weil ein enger Rahmen der einzige ist, der sich im Alltag über Monate durchhalten lässt, auch an einem vollen Freitagnachmittag mit wechselndem Personal am Tresen.

Es gibt noch einen zweiten Grund für die enge Fassung, und der ist weniger juristisch. Eine Praxis lebt davon, dass Patienten ihr in der Sache glauben. Sobald am Tresen etwas liegt, das nach Verkauf aussieht, bezahlt das nicht die Kammer, sondern das Vertrauensverhältnis. Die passive Auslage ist deshalb nicht nur die vorsichtiger Variante, sie ist auch die, die dem Verhältnis zum Patienten nichts wegnimmt.

Ob eine Praxis neutrale Information auslegt, entscheidet sie selbst. Wer es vorher schriftlich abgesichert haben will, kann seine Kammer fragen, und dann lohnt sich eine präzise Formulierung:

Es geht nicht um die Frage, ob eine Praxis werben darf, sondern um die Frage, ob eine Praxis auf eine Patientenfrage nach der Finanzierung eines Eigenanteils mit einer neutralen Information über Prüfwege antworten darf.

4. Der erste Prüfweg, der nichts kostet und nichts verspricht

Wenn ein Patient fragt, wo das Geld herkommen soll, gibt es einen ersten Schritt, der weder die Praxis noch den Patienten etwas kostet: nachsehen, was seine eigene gesetzliche Krankenkasse über ihr Bonusprogramm und ihre Satzung bereits vorsieht.

Das ist aus zwei Gründen der richtige Anfang. Erstens ist es Geld, für das der Patient bereits Beiträge zahlt. Zweitens setzt es keinen Vertrag voraus und verpflichtet zu nichts.

Zwei Dinge sind dabei sauber auseinanderzuhalten, weil sie im Gespräch ständig vermischt werden.

Der Beitrag. Der gesetzliche Leistungskatalog ist weitgehend derselbe, der Zusatzbeitrag der einzelnen Kassen ist es nicht. Was das im Monat ausmacht, kann jeder selbst nachsehen.

Das Bonusprogramm. Was eine Kasse anerkennt und was sie dafür gewährt, steht in ihrer Satzung. Welche Nachweise zählen, unterscheidet sich von Kasse zu Kasse erheblich.

Beim Bonus lohnt sich eine weitere Unterscheidung, weil sie regelmäßig für Enttäuschung sorgt. Manche Kassen zahlen einen Geldbonus aus, andere gewähren einen Zuschuss gegen nachgewiesene Kosten. Im ersten Fall kommt Geld an, im zweiten Fall wird ein Teil einer Rechnung erstattet, die vorher entstanden sein muss. Wer das verwechselt, rechnet mit einem Betrag, der so nie fließt. Für eine Praxis ist das der wichtigste Grund, sich aus der konkreten Rechnerei herauszuhalten: Es ist der Punkt, an dem eine gut gemeinte Auskunft am Tresen falsch wird.

Für Ihre Patientinnen und Patienten ist der Zahnbereich dabei oft der naheliegendste Einstieg, weil die jährliche Kontrolle in vielen Satzungen zu den anerkannten Nachweisen zählt. Das ist eine Beobachtung, keine Aussage über eine bestimmte Kasse, und sie ersetzt den Blick in die jeweilige Satzung nicht.

Zusammengerechnet werden diese beiden Punkte hier nicht, und im Gespräch sollten sie es ebenfalls nicht werden. Es sind zwei getrennte Hebel. Eine Summe daraus wäre eine Zahl, die niemand einhalten kann.

Ebenso wenig steht hier eine Aussage darüber, welche Kasse besser ist als eine andere, und schon gar keine Empfehlung, die Kasse zu wechseln. Der erste Schritt ist immer, bei der eigenen Kasse nachzusehen.

Für dieses Nachsehen gibt es ein kostenloses Werkzeug: kassenboost.de. Dort sind die Bonusprogramme der Kassen anhand der jeweiligen Satzungen ausgewertet. Die Seite wird von der Healio GmbH betrieben, ist kostenlos, verlangt keine Anmeldung und setzt keine Tracking-Cookies.

Wir fangen bewusst bei der größeren Betrachtung an. Über dieselbe Seite kann jeder selbst nachsehen, welche gesetzliche Kasse für seine Situation am meisten hergibt. Eine Rangliste geben wir dazu nicht aus, und einen Wechsel rufen wir auch nicht aus. Die Entscheidung bleibt beim Patienten. Der Zusatzschutz kommt erst danach.

Erst wenn dieser Schritt gemacht ist, wird die zweite Ebene interessant. Aus einem gehobenen Kassenbonus und einem passenden Zusatzschutz kann, je nach Tarif und persönlichen Voraussetzungen, ein Gesundheitsbudget von bis zu 3.000 EUR in zwei Jahren entstehen. Das ist eine Einordnung der Größenordnung und keine Zusage. Was bei einem einzelnen Menschen tatsächlich ankommt, hängt von seiner Kasse, seinem Vertrag und seinen persönlichen Voraussetzungen ab.

Die Reihenfolge ist dabei das Eigentliche: erst die richtige Kasse, dann den Bonus heben, und damit einen Zusatzschutz finanzieren. Das ist ein ganzheitlicher Blick auf die Versorgung statt eines Tarifvergleichs, und er gehört nicht in die Praxis, sondern an den Ort, an dem beraten werden darf.

5. Wenn die Behandlung schon angeraten ist: der Sofortschutz

Der häufigste Einwand gegen den ganzen Gedanken lautet: Zu spät. Der Plan liegt doch schon auf dem Tisch, wer jetzt noch etwas abschließt, bekommt dafür nichts mehr. In dieser Pauschalität stimmt das nicht.

Es gibt einen Baustein, der eine bereits angeratene oder sogar begonnene Behandlung mitversichert. Die Größenordnung liegt bei bis zu 1.500 EUR über zwei Kalenderjahre, höchstens 750 EUR in einem einzelnen Kalenderjahr. Das ist kein Ersatz für eine früh abgeschlossene Vorsorge, aber es ist der Unterschied zwischen einem Teilbetrag und gar nichts.

Zwei Bedingungen entscheiden darüber, ob das überhaupt greift, und beide sind zeitlicher Natur.

Der Baustein muss gewählt sein, bevor die Behandlung abgeschlossen oder in Rechnung gestellt ist. Wer erst mit der Schlussrechnung in der Hand anfängt zu suchen, ist zu spät dran. Das ist der Grund, warum der Zeitpunkt des Heil- und Kostenplans überhaupt eine Rolle spielt.

Und wenn sich eine Behandlung über den Jahreswechsel zieht, ist die Rechnungsstellung ein eigener Punkt. Weil die Obergrenze je Kalenderjahr gilt, kann es einen Unterschied machen, ob alles in einem Jahr abgerechnet wird oder verteilt. Das zu planen ist Sache des Patienten und seines Beraters, nicht Sache der Praxis.

Für Ihr Team ändert dieser Abschnitt nichts an der Linie. Er steht hier, damit Sie wissen, dass die Frage nach dem Eigenanteil auch dann noch nicht erledigt ist, wenn der Plan schon geschrieben ist. Wer Sie darauf anspricht, soll nicht mit einem Achselzucken nach Hause gehen. Dass es die Möglichkeit gibt, dürfen Sie sagen, und genau das ist Ihr Teil. Geprüft und entschieden wird danach außerhalb der Praxis.

6. Die Rollentrennung, sauber aufgeschrieben

Damit ist die Aufgabenverteilung beschreibbar.

Die Praxis klärt über die Behandlung auf, nennt die Kosten und weist, wenn danach gefragt wird, allgemein und ohne Umschweife darauf hin, dass es Prüfwege gibt. Anbieter, Verträge und Zahlen, die sie nicht selbst verantworten kann, nennt sie nicht. Sie fragt auch nicht nach, ob der Patient

inzwischen nachgesehen hat.

Der Patient entscheidet, ob ihn das interessiert. Er nimmt, wenn er möchte, außerhalb der Praxis von sich aus Kontakt auf. Diese Entscheidung ist freiwillig und für die Behandlung ohne jede Bedeutung. Wer nichts tut, wird genauso behandelt wie vorher.

Die externe Seite übernimmt alles, was Beratung ist: die Frage, welcher Weg zu welcher Situation passt, welche Bedingungen gelten, was ein Vertrag kostet und was er leistet. Diese Fragen gehören nicht in den Behandlungsraum, und zwar unabhängig davon, wie gut das Team informiert ist.

Praktisch heißt das: Das Team braucht keine Schulung in Versicherungsfragen. Es braucht genau einen Satz für den Fall, dass jemand fragt, und die Sicherheit, dass danach nichts mehr von ihm erwartet wird.

Drei Situationen decken fast alles ab, was am Tresen tatsächlich vorkommt.

Wenn jemand fragt, ob es eine Möglichkeit gibt, den Eigenanteil zu stemmen: „Ja, es gibt einen Weg, den Sie prüfen können. Dazu liegt vorne eine allgemeine Information. Ob das für Sie passt, können wir hier nicht beurteilen, das müssten Sie selbst klären.“

Wenn jemand wissen will, welche Versicherung die richtige ist: „Welche das ist, dürfen wir Ihnen nicht sagen, und wir wissen es auch nicht. Dass es einen Prüfweg gibt, sagen wir Ihnen gern. Wir behandeln, beraten tun dazu andere.“

Und auf die Frage, ob die Praxis etwas davon hat: „Geld bekommen wir dafür nicht. Dass ein angenommener Plan auch uns hilft, ist kein Geheimnis. Für Ihre Behandlung ändert sich dadurch nichts.“

Diese drei Antworten haben eine Gemeinsamkeit. Sie enden. Keine von ihnen öffnet ein Gespräch, in dem jemand aus dem Team in eine Beratung hineinrutscht, die ihm nicht zusteht. Wer merkt, dass eine Frage darüber hinausgeht, verweist nach außen und lässt es dabei.

7. Fünf Prüfgrenzen für jedes Material und jede Teamansprache

Diese fünf Sätze sind der Maßstab. Was einen davon verletzt, wird nicht eingesetzt, egal wie gut es sonst klingt.

DIE FÜNF PRÜFGRENZEN

1. Die Praxis informiert nur allgemein über eine Möglichkeit.
2. Sie empfiehlt keinen Versicherer, Tarif oder konkreten Abschluss.
3. Sie berät nicht zu Versicherungsbedingungen oder zur individuellen Eignung.
4. Patienten entscheiden selbst und nehmen außerhalb der Praxis freiwillig Kontakt auf.
5. Die Praxis erhält keine Vergütung oder erfolgsabhängige Gegenleistung.

Legen Sie diese fünf Punkte neben jeden Entwurf, der Ihnen vorgelegt wird, auch neben diesen hier. Sie sind der Grund, warum die Unterlage so zurückhaltend formuliert ist.

Ehrlich dazugesagt

Drei Dinge, die nicht im Kleingedruckten stehen sollten.

Es gibt nichts dafür. Für die Weitergabe an Patienten gibt es keine Vergütung, keine Prämie und keine Aufwandsentschädigung. Zuweisung gegen Entgelt ist berufsrechtlich verboten, und daran ändert dieses Material nichts.

Es ersetzt keine Prüfung. Das E-Book ist keine Rechtsberatung und keine berufsrechtliche Freigabe. Es ist eine Arbeitsunterlage.

Es verlangt nichts von Ihrem Team. Nichts darin fordert Ihre Praxis auf, Patienten ungefragt anzusprechen oder ihnen etwas auszuhändigen.

Wenn Sie darüber sprechen wollen

Zwanzig Minuten am Telefon oder im Videocall, ohne dass daraus etwas folgen muss. Was uns dabei am meisten hilft, ist Ihre Einschätzung aus dem Praxisalltag: ob die Linie in dieser Form trägt und an welcher Stelle sie im echten Betrieb bricht.

Termin: healio.de/partner

Und ein Wort zum Schluss, das über die Linie hinausgeht. Sie sind für viele Patienten die erste vertraute Ansprechperson, wenn es ums Geld geht. Niemand verlangt von Ihnen, jemanden anzusprechen, und diese Unterlage verlangt es ausdrücklich nicht. Aber wenn ein Patient von sich aus fragt, helfen Sie mit, ihn zu informieren, dass es eine Lösung gibt, die wir nicht an einen einzelnen Anbieter binden, sondern je Situation ansehen. Ob er sie nutzt, ist seine Entscheidung, und prüfen muss er selbst. Sie ihm auf eine offene Frage hin zu verschweigen, wäre ein Versäumnis, für das wir gemeinsam geradestehen.

Schluss

Arbeitsunterlage

Arbeitsunterlage für Praxis und Team, keine Patienteninformation. Ob eine Praxis neutrale Information auslegt, entscheidet sie selbst. Diese Unterlage ist keine Rechtsberatung.

Das ist Werbung, keine Rechtsberatung und keine berufsrechtliche Freigabe. Die Healio GmbH vermittelt Versicherungen. Erstinformation: healio.de/erstinformation.

Healio GmbH, Hamburg, healio.de. Direkt: Frank Steinfurt, 0176 241 531 88.